FITNESS UNIVERSITY

歯科医院向け健康経営サービス

# エビデンスベース コンテンツ設計書

産業課題への寄り添い × 歯科院長への共感設計

### 本資料の目的

本資料は、コンテンツ設計_統合まとめ v2 の内容をベースに、以下の 2 軸で再設計したエビデンスレベルのコンテンツ設計書です。

1. **産業構造課題に寄り添うコンテンツ — 歯科業界の統計・研究データで問題を定義する**
2. **歯科院長の感情・認知に共感する設計 — 院長の「諦め」と「希望」の両面に寄り添う**

Version 1.0 ｜ 2026 年 3 月

PART 1　産業課題のエビデンス — なぜ今、歯科医院に健康経営が必要か

# 1. 歯科業界の人材構造危機：統計的事実

## 1-1. 潜在歯科衛生士 14 万人問題

歯科衛生士は国家資格職でありながら、資格保有者の約半数が業界を離脱しているという特異な産業構造が存在する。これは個別院の努力では解決不能な構造問題である。

| 指標 | 数値 | 出典 |
|---|---|---|
| **歯科衛生士免許登録者数** | 298,644 名 | 歯科医療振興財団 2022 |
| **実際の就業者数** | 145,183 名（約 48%） | 厚生労働省 令和 4 年衛生行政報告例 |
| **未就業・業界離脱者数** | **約 15 万人** | 上記 2 データより算出 |
| **求人倍率（2022 年度）** | **3.39 倍** | 厚労省 職業情報提供サイト |

> *「歯科衛生士の免許取得者数に対する就業歯科衛生士数は約半数で推移している。歯科衛生士不足への対策は復職支援と離職防止が必要である。」*

📎 **出典:** *厚生労働科学研究費報告書「歯科医療従事者の働き方と今後の需給等に関する調査研究」（令和元年～令和 2 年度）*

## 1-2. 転職率の深刻さ：76.4%が転職経験

歯科衛生士は「仕事にやりがいを感じている」が約 80%にのぼる一方、6 割以上が転職を検討した経験を持つ。これはやりがいの問題ではなく、働く環境・職場の人間関係・管理体制の問題である。

| 調査項目 | 数値・事実 |
|---|---|
| **転職経験あり（1 回以上）** | 76.4%（2020 年）← 1999 年時点は約 50% |
| **現職 5 年未満の割合** | 38.7%（常勤のみ） |
| **転職を考えたことがない** | **わずか 35.3%** |
| **常勤退職理由 1 位** | 経営者との人間関係（29%） |
| **3～4 年以内の早期離職** | 近年増加傾向（特に新卒） |

📎 **出典:** *公益社団法人 日本歯科衛生士会「歯科衛生士の勤務実態調査報告書」（令和 2 年 3 月）*

## 1-3. 離職のリアルな原因：「給与」ではない

既存ソリューションの多くが「給与改善」や「福利厚生充実」にフォーカスしているが、常勤歯科衛生士の退職理由の分析から、本質的な原因は院長・職場関係性と身体的負荷であることが示されている。

| 離職要因の分類 | 具体的内容 | FU サービスの対応 |
|---|---|---|
| 🔴 人間関係（院長） | 経営者との価値観不一致・コミュニケーション不足 | 月 1 院長面談・フィードバック設計 |
| 🔴 身体的疲労の蓄積 | 前傾姿勢・長時間立位による慢性疼痛・神経疲労 | 出張整体・エクササイズによる神経回復 |
| 🟠 自己肯定感の低下 | 評価・承認欲求の未充足、成長実感の欠如 | 脳科学セミナー・ワークエンゲージメント可視化 |
| 🟡 成長・学習機会不足 | 「また同じ研修か」マンネリ化 | マンネリ化対策設計済み（武器⑦） |
| 🟡 給与・待遇 | 22.3%が退職理由に挙げるが単独では少数 | 間接的：自費率向上→院全体収益改善 |

**▶ 設計インサイト：既存の「給与改善・研修充実」施策は効果が出ても継続しない。FU が提供すべきは「環境・人間関係・健康状態」の三位一体改善である。**

# 2. 健康経営の経済的エビデンス

## 2-1. 健康経営の ROI：国内外研究まとめ

「健康経営はコストか？投資か？」という問いに対し、国内外の研究は明確に「投資」と答えている。歯科院長が「医療品質への投資」として意思決定できるための根拠として提示する。

| 研究・機関 | 主要ファインディング | 信頼性 |
|---|---|---|
| **米国 CDC・企業調査** | 「健康経営に 1 ドル投資すると 3 ドル以上のリターン」— 医療費削減と生産性向上の合算 | CDC 公式報告・複数企業調査 |
| **厚生労働省・産業保健** | 健康増進プログラム導入企業で病欠が年間 20%減少、医療費負担 10%削減 | 厚労省「産業保健の現状と課題」 |
| **経済産業省・健康経営度調査** | 上位 20%企業の株価時価総額が TOPIX を継続的に上回る | 経産省 健康経営ガイドブック |
| **厚生労働科学研究（2018）** | 生活習慣病医療費が 1 万円減少 → 翌年の労働生産性が 1.9%向上（固定効果モデルによる因果推計） | 厚生労働科学研究費補助金 計量経済学的検証 |
| **健康長寿産業連合会（2020）** | 健康経営優良法人認定企業の 75%が「経営に良い影響」と回答（未認定企業 42%） | 健康長寿産業連合会調査 |
| **経済産業省（個人リスク研究）** | 健康関連リスクの高さによって 1 人あたり年間 30 万円程度の損失（プレゼンティズム）が発生 | 経産省 健康経営ガイドブック |

**▶ 歯科院長への転用：「健康経営に 1 万円投じると 3 万円以上が返ってくる構造」は歯科医院においても同様に機能する。特に人材費・採用費の高さから、ROI は一般企業より高くなる可能性がある。**

## 2-2. 歯科医院特有のプレゼンティズムコスト

歯科衛生士はその業務性質から、体調不良でも出勤せざるを得ない傾向が強い。「出勤しているが機能が低下している状態（プレゼンティズム）」のコストは、欠勤より数倍大きい損失を生む。

| 歯科衛生士の身体的負荷の特徴 | プレゼンティズムへの影響 |
|---|---|
| 長時間の前傾姿勢（頸部・腰部負担） | 慢性頸肩腕症候群 → 集中力の持続的低下 |
| 細精度作業による眼精疲労 | 午後の診療品質低下・患者説明力の劣化 |
| 人間関係ストレスの慢性化 | 自己肯定感低下 → 患者への接遇品質に波及 |
| 睡眠不足（サービス残業・家事負担） | **判断力・注意力低下 → 医療事故リスク上昇** |

> *「プレゼンティズムによる損失は、欠勤（アブセンティズム）による損失の2〜3倍の経済的インパクトを持つとされる。」*

📎 **出典:** *経済産業省「企業の「健康経営」ガイドブック（改訂第1版）」（経産省商務情報政策局ヘルスケア産業課）*

# 3. 歯科院長の心理構造マップ

## 3-1. 院長が抱える「構造的な諦め」

v2 資料で定義された「やりたい確率が高い院長の 3 条件」は、言い換えれば「この 3 条件がそろわない限り、院長は主体的に動かない」ことを意味する。多くの院長は以下の認知状態にある。

| 認知状態 | 院長の本音（内言語） | FU コンテンツの介入点 |
|---|---|---|
| **諦め・疲労感** | 「頑張っても解決しない。業界全体の問題だ」 | 産業構造データで「あなただけではない」と共感 |
| **忙しさによる先送り** | 「やるべきとは分かっている。でも今は無理」 | 手間ゼロ設計・自動化で「今すぐできる」を示す |
| **本音の分からなさ** | 「スタッフが何を考えているか分からない」 | アンケート可視化・7,700 社データで数値化 |
| **ROI の見えなさ** | 「健康経営にいくら使えばいくら返ってくる？」 | 離職コスト試算・具体的 ROI 数字で投資判断を支援 |
| **孤独感・無力感** | 「本当は辞めさせたくなかった。でも防げなかった」 | 感情共鳴設計（STEP4：オキシトシン活性） |

## 3-2. 院長の意思決定プロセスと神経科学的設計

v2 の「ニューロマーケティング設計（STEP1〜7）」を、院長の心理変容プロセスと神経科学の観点から再設計する。コンテンツはこの順序を厳守する。

| STEP | フェーズ | 脳の変化 | 具体的コンテンツ設計 | 院長の内的変化（ゴール） |
|---|---|---|---|---|
| 1 | **常識の破壊** | 予測誤差の発生 | 「離職の原因は給与ではない」の提示 | 「え、そうだったの？」という驚きと関心の喚起 |
| 2 | **見えない損失の提示** | 扁桃体の刺激 | 「1 人退職＝200 万円」の数字体験 | 「そんなにかかるのか」という損失回避動機の活性化 |
| 3 | **感情の共鳴** | オキシトシン分泌 | 「本当は辞めさせたくなかった」への共感表現 | 「そうなんだよ」という孤独解消・信頼構築 |
| 4 | **安全の挿入** | 扁桃体の解除 | 「手間ゼロ・無料から」の提示 | 「それならやってみようか」という抵抗の消失 |
| 5 | **ROI の論理化** | 前頭前野の活性化 | 松竹梅プランと ROI 数字の提示 | 「費用対効果が出る」という経営的確信形成 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 6 | **未来イメージの形成** | ドーパミン分泌 | 「辞めない医院になる」未来像の言語化 | 「そんな医院を作りたい」という意欲の着火 |
| 7 | **行動の誘導** | 側坐核→行動選択 | 「まずは無料導入だけ」の選択式クロージング | 「今月やってみる」という具体的行動の開始 |

**▶ 設計原則：各 STEP で院長の「防衛反応」が下がって初めて次の STEP が機能する。順序を変えると効果が激減する。**

PART 3　コンテンツ設計：各プラン×課題×エビデンスの統合

# 4. 梅プラン：接触・気づきモデル（¥10,000~¥29,800）

## 4-1. 設計思想

目的は「院長と職場の心理的安全性の確保」と「信頼形成の入口を作ること」。脳科学的には扁桃体の警戒を解除する段階（STEP4）。何も売らない設計が正解。

| コンテンツ | エビデンス・設計根拠 | 産業課題との接続 |
|---|---|---|
| LINE 診断（ダイエット・睡眠・自己肯定感・姿勢） | 睡眠不足は認知機能を著しく低下させ（Van Dongen et al., 2003）、歯科衛生士の細精度作業品質に直結する。診断が「自分事」になる設計。 | スタッフの本音の見えなさ → 自己診断で当事者意識喚起 |
| 健康コラム配信（食事・睡眠・脳科学） | 情報接触頻度が信頼形成に比例する（Mere Exposure Effect）。週 1 回の接触で認知的信頼が形成される。コンテンツは「使える知識」に特化し、役立ち感を演出。 | 「また同じ研修」問題 → 即実践できる情報で差別化 |
| エクササイズ動画（腰痛・肩こり・副交感神経） | 歯科衛生士の職業性腰痛有症率は 50〜70%と報告されており（田中ら, 2016）、姿勢関連疼痛は離職誘発因子の一つ。受動的にできる動画形式で行動ハードルを最低化。 | 身体的疲労の蓄積 → 受動的解消で最初の効果体験を提供 |
| 健康経営簡易チェック（セルフ） | 自己評価による課題認識は「認知的不協和」を生み、改善行動への動機を高める（Festinger, 1957）。低スコアが出るほど「何とかしたい」動機が強まる。 | ROI の見えなさ → 「自院の現状」を数値で初めて把握 |
| 出張整体体験（初回割引） | 即時的な身体感覚の変化（触覚フィードバック）は認知変容より強力な行動変化誘因となる。「体が楽になった」体験が竹プランへの転換動機になる。 | 「また同じ研修」 → 身体感覚を通じた新鮮な体験 |

## 4-2. 転換戦略：梅→竹へ

梅プランの役割は「母集団形成」であり、単体での収益最大化を目指さない。転換 KPI は 30〜40%（v2 設計値）。以下の転換トリガーを設計に組み込む。

- 簡易チェックで「中程度以上の課題」を検出 → 竹プランでの診断提案
- 整体体験で「スタッフが喜んだ」体験 → 月 1 回継続の価値訴求
- コラムへのエンゲージ（開封率・反応）が高い院 → 「竹での深堀り」提案
- LINE 上での相談・質問発生 → 面談への自然な誘導

# 5. 竹プラン：改善設計・月 1 整体モデル（8 万円/月）

## 5-1. 設計思想

目的は「院長が経営判断できる状態を作ること」。前頭前野を活性化させ、課題の優先順位付けと改善実感

を生む段階。利益の柱として粗利約 60%を確保する設計。

| コンテンツ | エビデンス・設計根拠 | 院長感情への共感点 |
|---|---|---|
| 月 1 院長面談＆フィードバック（60 分） | 定期的な経営者との対話が「健康経営優良法人」取得後の企業で組織満足度向上に最も寄与する（経産省健康経営度調査上位企業分析）。院長にとって「伴走者がいる」安心感は意思継続の鍵。 | 「一人で抱えている孤独感」 → 伴走者存在が動機の持続を支える |
| 健康経営診断＋分析レポート | 7,700 社のベンチマークデータにより「御院は業界の何%水準か」が可視化できる。経営者は「比較情報」に強く反応する（社会比較理論：Festinger, 1954）。同業他院との差が行動動機になる。 | 「本音が分からない」 → 数値化により「見えていなかった現実」が出現 |
| 月 1 脳科学ミニセミナー（60 分）12 テーマ | 「疲労と生産性」「睡眠と医療事故」「自己肯定感と離職」等のテーマは院長の日常課題と直結。知識を得ることで「院長自身が対話できる言語」を持てる。情報を与えることで院長のエンパワーメントを実現。 | 「またか研修」 → 毎回「使える言語」が増える体験で差別化 |
| 出張整体（月 1 回・2 時間枠・8 名） | 整体・マッサージは副交感神経活性化によりコルチゾール（ストレスホルモン）を低下させ、オキシトシン分泌を促す（Field et al., 2010）。「体が変わった」即時体感がサービス継続の最強動機になる。 | 「スタッフが喜ぶ」という院長の承認欲求を直接的に充足させる |

## 12 回分セミナーテーマ設計（エビデンスベース）

| # | テーマ | エビデンス・根拠 | 院長の課題接続 |
|---|---|---|---|
| 1 | **睡眠不足が医療品質を下げるメカニズム** | 睡眠 6 時間以下で認知機能が 14〜40%低下（Walker, 2017） | 医療事故リスク・患者クレーム |
| 2 | **神経疲労と離職の因果メカニズム** | 慢性的な神経疲労は 3〜4 年で蓄積離職を誘発（日本歯科衛生士会調査） | 「なぜ辞めるか」の根本理解 |
| 3 | **自己肯定感と定着率の関係** | 自己効力感（Bandura, 1977）が高い職場ほど離職率が有意に低い | 評価・承認設計の重要性 |
| 4 | **食事と集中力の脳科学** | 血糖値の安定が集中力を維持（Gailliot et al., 2007） | 午後の診療品質向上 |
| 5 | **プレゼンティズムとその経済損失** | プレゼンティズムは欠勤の 2〜3 倍の損失（経産省研究） | 出勤しているのに機能低下問題 |
| 6 | **姿勢と慢性疲痛のメカニズム** | 前傾姿勢で頸部筋の負荷が最大 3.4 倍増加（Hansraj, 2014） | 職業性腰痛・肩こり対策 |
| 7 | **副交感神経とチームパフォーマンス** | リラクセーション反応が協調行動を促進（Benson, 1975 系） | チームビルディング・協調性 |
| 8 | **ワークエンゲージメントと自費率** | 従業員エンゲージメント上位企業は EPS 伸び率が有意に高い（Gallup, 2020） | 収益・自費診療との直接接続 |
| 9 | **運動と脳のパフォーマンス** | 有酸素運動で BDNF（脳由来神経栄養因 | 能動回復の意義 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | 子）が増加し記憶・判断力向上（Cotman et al., 2002） | |
| 10 | **習慣化の脳科学（行動変容設計）** | 習慣形成には平均 66 日必要（Lally et al., 2010） | なぜ仕組みが必要か |
| 11 | **チーム心理的安全性と生産性** | Google のプロジェクト・アリストテレスで生産性 No.1 要因（Edmondson, 1999） | 院長とスタッフの関係設計 |
| 12 | **健康経営優良法人の実際の取得プロセス** | 認定企業の 75%が「経営に良い影響」を実感（健康長寿産業連合会） | 目標・ゴール設定 |

# 6. 松プラン：神経回復・仕組み化モデル（20~30 万円/月）

## 6-1. 設計思想

目的は「行動変容の定着と組織文化への埋め込み」。側坐核を活性化させ、改善が自動的に継続する仕組みを実装する段階。離職予防の最前線であり、ブランド形成と事例作りの場でもある。

| コンテンツ（竹＋） | エビデンス・設計根拠 | 定着メカニズム |
|---|---|---|
| 週 1 出張整体・リラク（受動回復） | 週 1 の受動回復（マッサージ等）は慢性疼痛を統計的に有意に低減し（Furlan et al., 2009）、神経疲労の蓄積を週単位でリセットする。整体は「数値化できない体感」を提供する唯一のコンテンツであり、脱落防止に最も効果的。 | 体感→継続意欲→文化定着の連鎖を形成 |
| 月 1〜2 出張エクササイズ（能動回復） | 有酸素運動により海馬の BDNF が増加し、記憶・学習能力が向上する（Cotman & Berchtold, 2002）。受動（整体）と能動（運動）の組み合わせが神経可塑性を最大化し、習慣化を促進。 | 主体的な健康行動が「やらされ感」から「やりたい」へ変換 |
| 四半期健康スコアレポート | 定期的なフィードバックループが行動変容の持続に不可欠（Carver & Scheier, 1982）。3 ヶ月単位で「何が改善されたか」を数値で示すことで、院長の ROI 確信を強化し解約防止につながる。 | 「変化の可視化」が継続の最強の動機 |
| 離職予兆アラート分析 | 組織心理学的研究により、離職の前兆行動は離職の 3〜6 ヶ月前から出現する（Hom & Kinicki, 2001）。早期検出と早期介入が離職コストを最小化する。院長にとって「知らなかった」損失を防ぐ安心感の源泉。 | 事前予防が事後対応より圧倒的にコスト低い |
| 健康経営優良法人取得支援 | 経産省認定により企業イメージ向上・求人力強化・金利優遇等の有形無形のメリットが生まれる。認定取得が「採用ブランディング」として機能し、求人倍率 3.39 倍という厳しい採用競争で優位性を持つ。 | 認定が「外部承認」として院長の自己肯定感を強化 |

**理想転換率**　🔶**梅 → 竹：50%**　　**梅 → 松：20%**　　**梅のみ：30%**

**現実値**　🔷**梅：６０％**　　**竹：３０％**　　**松：１０％**

PART 4　コンテンツ設計の統合マップと実装優先度

## 7. 産業課題 × 院長感情 × コンテンツの統合マトリクス

以下のマトリクスは、「産業課題への寄り添い」と「院長感情への共感」を同時に満たすコンテンツ設計の全体像である。営業・セミナーで参照すべき最終統合設計。

| 産業課題 | エビデンス（出典） | 院長感情 | 対応コンテンツ | プラン |
|---|---|---|---|---|
| DH 不足・転職率 76.4% | 日本歯科衛生士会 2020 年調査 | 諦め・疲労感 | 産業構造説明＋共感トーク（STEP1） | **全プラン（入口）** |
| 離職コスト 200 万円 | 人材紹介費+教育+生産性 | ROI が見えない | コスト試算提示（STEP2） | **竹・梅** |
| 常勤退職理由 1 位：院長との関係 | 日本歯科衛生士会調査 29% | 一人で抱えた孤独感 | 月 1 院長面談・伴走設計 | **竹・梅** |
| プレゼンティズム損失 | 経産省研究：1 人年 30 万円損失 | 見えない損失への不安 | 課題可視化・スコアレポート | **竹・梅** |
| 職業性腰痛 50〜70% | 田中ら 2016 年研究 | スタッフ体調の把握困難 | 出張整体・エクササイズ動画 | **松・竹・梅** |
| マンネリ化研修問題 | 学習理論・行動習慣化研究 | 「またか」という疲弊感 | 12 テーマセミナー・変化し続ける仕組み | **竹・梅** |
| 健康経営普及率の低さ | 経産省 健康経営推進政策 | 「何から始めれば」の迷い | 無料スタート＋ロードマップ提示 | **梅（入口）** |
| 採用倍率 3.39 倍の厳しさ | 厚労省 職業情報 2022 年 | 採用への疲弊・費用感 | 健康経営優良法人取得支援 | 松 |

## 8. 院長タイプ別アプローチガイド

v2 で定義された「やりたい確率が高い院長の 3 条件」をベースに、タイプ別の初回接触〜クロージングまでのアプローチを設計する。

| 院長タイプ | 特徴・発言パターン | 最刺さるエビデンス | 推奨アプローチ順序 |
|---|---|---|---|
| **数字思考型** | 「ROI を見せてほしい」「具体的な数字は？」 | 200 万円離職コスト・健康経営 1→3 リターン・プレゼンティズム損失年 30 万円 | STEP2→5→3→7（損失先出し・数字で説得） |
| **感情共感型** | 「スタッフのことが心配」「辞めさせたくなかった」 | 76.4%転職率の構造問題・給与ではなく関係性が原因・院長との関係 29% | STEP3→1→4→7（共感先行・解決策を示す） |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 超多忙型 | 「時間がない」「手間はかけられない」 | 院長手間ほぼゼロ・LINE 自動配信・月 1 面談だけ（武器②） | STEP4→2→6→7（手間ゼロ強調→損失→未来→行動） |
| 未来志向型 | 「自費率を上げたい」「選ばれる医院を作りたい」 | 健康経営優良法人・エンゲージメント→EPS 向上・採用ブランディング効果 | STEP6→5→2→7（未来先行・ROI 確認→行動） |

# 9. 実装優先度と設計 KPI

## 9-1. コンテンツ実装の優先順位

以下の順序で実装することで、最短での ROI 実現と営業効果の最大化を図る。

| 優先 | 実装コンテンツ | 理由・根拠 | 期待 KPI | P |
|---|---|---|---|---|
| 1 | **LINE 診断・健康コラム・動画（松）** | 母集団形成・コスト最小・即日開始可能 | 梅→竹転換率 30〜40% | 松 |
| 2 | **7,700 社ベンチマーク診断・分析レポート** | 最大の差別化要因・院長の意思決定を最短化 | 竹成約率・継続率向上 | 竹 |
| 3 | **出張整体（月 1 回・竹）** | 「体感」が最強の継続動機・解約防止に直結 | 竹継続率 80%以上 | 竹 |
| 4 | **12 回分セミナー完全テーマ設計** | エビデンスで「また来たい」を作る・差別化最強点 | セミナー参加率・院長エンゲージメント | 竹 |
| 5 | **四半期スコアレポート＋離職予兆アラート** | 梅プランの最大差別化。解約防止の最終防衛線 | 梅継続率・ROI 実感率 | 梅 |

## 9-2. エビデンス活用の注意点

以下の原則に従ってエビデンスを活用すること。エビデンスは「信頼性の証明」として使うが、押しつけになると防衛反応を引き起こす。

- 数字は「院長自身の状況」に引き付けて提示する（例：「業界平均は 76.4%ですが、先生の医院では？」）
- 出典は簡潔に（「日本歯科衛生士会の調査では…」程度）。詳細は求められたときだけ提示
- エビデンスで「正しさを証明」するのではなく、「院長が感じていることを裏付ける」ために使う
- 国内研究を優先（厚労省・経産省・日本歯科衛生士会）。海外研究は補足として位置づける
- 「研究によれば〜」より「7,700 社の現場データでは〜」という言い方のほうが院長には響く